

IMC - 27.76

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

NEWTON OG PINOTTI

IDADE: 75a PESO: 95 ALTURA: 185 PROFISSÃO: Engenheiro
SINTOMAS: Sonolência durante dia / Refluxo gástrico
QUEIXAS: Acorda cansado / Sonhos tumultuados / engasgo
MEDICAMENTOS: Glifage / Trasto / xabarna / Antitrombotico
HAS - D.M
MÉDICO: Drº Augusto / Drº Luis
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S
HORA QUE DORME: 23-24 HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILHO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: oral BANHEIRO: 2x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 43
OVERLAP: Amada MALLAMPATI: IV IAH: 57.5 SPO2: 74%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 2x RM / Stent / Ablação
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Aritmia
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Hipotireoidismo

07/06/24 marc EVORA Full
Hourel
agua

17/06 P: 7 - 13 cmH₂O
24 IAH = 23.8 e ltr
m de uso: 5h42'

fixei a pressão
em 12 cmH₂O.

30/01/25 P: 13.8 cmH₂O
IAH = 7.8 e ltr (AC = 9.4) (22 42 e 63)
M. de uso: 5h27' musculação.
fuga = 10.5 e pm.



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

PSQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELIZABETH MADRUGA FORTES
CRM-SP 62.856

NOME: Wenden Francisco Silva
EXAME nº: 5530
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 15/11/2023
IDADE: 39 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h37min e concluído às 04h34min. A latência para o sono foi de 23 minutos e a latência para o estágio REM, de 173 minutos. O tempo total de sono foi de 370,5 minutos (06h10min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 89,9%. A distribuição do sono mostrou 7,7% de estágio 1, 58,8% de estágio 2, 15,1% de estágio 3 e 18,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 18 minutos em vigília, ocorreram 64 microdespertares (índice: 10,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 54,1/hora, sendo 25,8 apneia/hora e 28,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 55,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 87%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (54,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (55,9/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 80 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 23 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (173 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (89,9%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (10,4/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (7,7%; normal: 5%) e 2 (58,8%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (18,4%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 3 (15,1%; normal: 15-16%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 14 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Rua Guilherme, 673 salas 51 e 52
Office Tower - Centro - São José dos Campos - SP
130 - fones: (12) 3941-2449 / 3943-2162

www.clinicaalbertoremesar.com.br